

RAPPORT MEDICAL COMPLET

Jumeau Numerique Cardiovasculaire

IDENTIFICATION DU PATIENT

Nom du patient	John Doe
Date du rapport	10/06/2026 a 21:45
Analyses de risque	10 consultation(s)
Analyses ECG	3 analyse(s)
Radiographies	7 radiographie(s)

RESUME DU DERNIER BILAN

RISQUE ELEVE

87.6%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Tension	180 mmHg — Hypertension
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Angine effort	Oui
Depression ST	1.5

ANALYSES DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Consultation 1 — 2026-04-20

Risque : FAIBLE

28.6%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	— bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 2 — 2026-05-20

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 3 — 2026-05-30

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 4 — 2026-06-03

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 5 — 2026-06-03

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 6 — 2026-06-03

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 7 — 2026-06-03

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 8 — 2026-06-10

Risque : FAIBLE

1.3%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	117 mmHg — Normal
Cholesterol	190 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 9 — 2026-06-10

Risque : FAIBLE

1.4%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	120 mmHg — Normal
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Non
ECG repos	Normal
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Non
Depression ST	0.0
Pente ST	Montante
Vaisseaux (ca)	0
Thalassemie	Normal

Consultation 10 — 2026-06-10

Risque : ELEVE

87.6%

Age	25 ans
Sexe	Homme
Type douleur	Asymptomatique
Tension	180 mmHg — Hypertension
Cholesterol	200 mg/dL — Normal
Glycemie a jeun	Oui
ECG repos	Anomalie onde ST-T
FC maximale	150.0 bpm
Angine d'effort	Oui
Depression ST	1.5
Pente ST	Plate
Vaisseaux (ca)	1
Thalassemie	Defaut fixe

ANALYSES ECG

ECG 1 — 2026-05-02

Classification	Supraventricular
Confiance	85.0%
Conseil clinique	Battement prématuré des oreillettes. Surveillance recommandée.

ECG 2 — 2026-05-20

Classification	Normal
Confiance	100.0%
Conseil clinique	Rythme cardiaque normal. Continuez vos bonnes habitudes.

ECG 3 — 2026-06-10

Classification	Normal
Confiance	100.0%
Conseil clinique	Rythme cardiaque normal. Continuez vos bonnes habitudes.

RADIOGRAPHIES CARDIAQUES

Radiographie 1 — 2026-05-02

ANOMALIE DETECTEE

No Finding	45.3%
Cardiomegaly	3.4%
Consolidation	1.0%
Edema	0.8%
Pneumonia	0.5%

Radiographie 2 — 2026-05-04

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

Radiographie 3 — 2026-05-04

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

Radiographie 4 — 2026-05-20

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

Radiographie 5 — 2026-05-30

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

Radiographie 6 — 2026-05-30

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

Radiographie 7 — 2026-06-10

ANOMALIE DETECTEE

Cardiomegaly	85.7%
Atelectasis	41.9%
Effusion	35.4%
No Finding	14.3%
Pneumonia	1.6%
Edema	1.5%

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Niveau de risque	ELEVE — Consultation cardiologique urgente
Priorite	Consultation dans les 48h
Tension arterielle	Hypertension — traitement a envisager
Angine d'effort	Presente — evaluation cardiologique necessaire

Ce rapport a ete genere automatiquement par Cardio Digital Twin. Modele LR Optuna entraine sur 920 patients (Cleveland, Hungarian, Switzerland, Long Beach). Il ne remplace pas un examen clinique complet ni l'avis d'un professionnel de sante qualifie.